

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	鼻胃管灌食技術 Nasogastric Feeding				
編號	A31000-Q05-W-A23	制定者	賴怡如	公布日期	89 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.9 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員、照顧服務員能正確操作鼻胃管灌食技術。

二、範圍

護理部各單位，除兒科單位不適用（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

經由鼻胃管供給病人營養或治療藥物。

（二）用物準備

1.治療盤 1 個，內置下列用物：

灌食空針 1 支、當餐灌食的食物或藥物、杯子 1 個（內盛溫開水）。

2.治療巾 1 條。

3.彎盆 1 個（視需要）。

4.清潔手套 1 雙（視需要）。

5.聽診器 1 付。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對預定執行醫囑，於核對狀態核簽“正確”。	
2. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋鼻胃管灌食的過程及目的，並詢問是否需要如廁。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
3. 洗手。	

主題名稱	鼻胃管灌食法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/8

步驟	說明
4. 備妥用物，將護理工作車推至病人單位，再次核對病人。	1. 確認管灌飲食種類、名稱及有效日期，無過期情形。管灌食物採隔水加熱，溫度約 37.8-40.5°C，太燙易造成腸胃道黏膜損傷，過冷則會使腸胃痙攣不適。 2. 藥物須磨粉泡水（無法磨粉之藥物建議醫師更換藥物）。
5. 拉床簾及開燈。	尊重病人隱私權及維持良好光線。
6. 協助病人採坐臥姿或半坐臥姿，若無法坐起則協助其右側臥並稍微抬高頭部。	使溶液容易流入胃內，降低肺吸入發生機會。
7. 視需要準備治療巾鋪於病人頸部及胸前。	保護病人衣服及床單的清潔、乾燥。
8. 鬆開盤繞之鼻胃管，先反折鼻胃管再打開末端的塑膠蓋。	
9. 確認鼻胃管的位置是否在胃內（以二種方式確認）。	1. 先確認鼻胃管之固定公分數，是否在 55-60 公分之間（刻度 1 到刻度 2）。 2. 用反抽方式確認是否有胃酸或未消化物殘留。 3. 將鼻胃管末端沒入盛有涼開水或生理食鹽水的碗中，看有無連續性氣泡產生。 4. 用灌食空針注入 10-20mL 空氣於胃管內，將聽診器放在病人上腹部，聽有無氣體咝咝聲。 5. 抽取胃酸送檢驗科檢驗 pH 值。 6. 若仍有疑慮可以照射 CXR 進行確認。 ※第 1 項為必須確認項目，第 2~6 項選擇其中一種方式確認。
10. 套上灌食空針，以輕緩的力量反抽胃內容物，觀察胃內容物的殘存量及性質。	1. 觀察胃內容物殘存量可用來評估食物吸收狀況，作為下次灌食量的依據。 2. 胃內容物殘存量少於 50mL，表示消化良好，可給予灌食。 3. 胃內容物殘存量若超過 100mL 或大於前次管灌的一半量，則暫時不予灌食，於一小時後再評估一次。 4. 胃內容物殘存量若出血或咖啡色性狀物請告知醫師。 5. 胃液內含豐富電解質，故抽出的胃內容物需再緩慢推入胃內。

主題名稱	鼻胃管灌食法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
	6. 若有空氣抽出，勿將空氣推回胃內。
11. 反折鼻胃管並將灌食空針的針筒銜接於末端，倒入約 20mL 的溫開水於灌食空針內，使溫開水自然且緩慢地流入鼻胃管內。	灌食前先灌入開水的目的： 1. 再次確定鼻胃管是否通暢。 2. 潤濕鼻胃管，以防止食物黏著於管壁上。 3. 可先刺激胃液分泌。
12. 當開水快流至灌食空針之頸部前，將鼻胃管反折，再把指定食物倒入針筒內，控制流速讓食物緩緩流入胃內。	1. 食物液面至胃的距離約 30-45 公分，藉由重力原理流入胃中，速度盡量緩慢，若食物流動過緩，注意病人反應。 2. 反折鼻胃管可避免空氣進入胃部，造成病人腹脹。 3. 首次灌食量一次不超過 150-250 mL，每 8-12 小時增加 30-60 mL，直到獲取所需的熱量。 4. 每次灌食量約 200-350mL，總量不可超過 500mL，以免引起腹瀉、腹脹、胃痙攣性疼痛及逆流性嘔吐致吸入性肺炎，灌食時間至少 15-20 分鐘。 5. 營養品與藥物需間隔 30 分鐘，分開灌食。
13. ，再灌入約 20-30 mL 的溫開水，當溫開水流至灌食空針之頸部時，反折鼻胃管，避免空氣進入鼻胃管或管內液體流出。	灌食後灌溫開水之目的： 1. 清除鼻胃管中剩餘的食物，避免食物在鼻胃管內發酵。 2. 使病人能獲得全部的營養。 3. 鼻胃管充滿水可預防空氣進入造成腹脹。 4. 防止配方食物濃度過高，造成高張性脫水。
14. 將灌食空針取下，栓上鼻胃管的塑膠蓋後固定，需要時以安全別針將過長的管子盤繞固定於病人衣服上。	
15. 請病人維持坐姿或半坐臥姿至少 30 分鐘。	以助消化，勿立刻翻身及拍痰，防止逆流性嘔吐。
16. 移除治療巾、拉開床簾，並整理病人單位。	
17. 清潔用物後，歸回原位。	
18. 工作後洗手。	
19. 在電腦 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
20. 記錄：胃內容物之殘存量、灌食配方的種	評估病人營養、水分及電解質等資料。

主題名稱	鼻胃管灌食法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
類及灌食量、灌食時間及病人反應；。若需記錄輸出量者，則灌入之開水量亦須記錄。	護理人員應追蹤：胃內容物之殘存量、灌食配方的種類及灌食量、灌食時間及病人反應，並於護理紀錄中呈現。

(四) 注意事項

1. 鼻胃管灌食方法可分成兩種：

(1) 間歇性灌食法：使用灌食袋或利用灌食空針重力灌食，一天灌食量平均分 4-6 次灌食。

(2) 連續性灌食法：平均一天 8-24 小時持續灌食，用於病人腸胃道一時無法接受大量食物時，它可避免病人發生腸胃痙攣、噁心、嘔吐等副作用，其方法有兩種：

A. 利用重力引流慢慢滴入。

B. 使用灌食幫浦，可自動控制灌食的速度及灌食量。

2. 管灌食物若為袋裝或罐頭食品，使用前需檢查食物名稱、濃度及有效期限，連續性灌食每餐灌食時間，應以 4-6 小時為限，罐頭食品應於開封 24 小時內使用完畢（開封後置於冰箱保存）。

3. 勿灌入易產氣或油膩食物，且須注意食物是否新鮮，有無異味或沉澱物。

4. 灌食中病人若呈現腹瀉、嘔吐等異常現象時，應先停止灌食並通知醫師處理。

5. 每日執行鼻胃管護理：

(1) 檢查膠布黏貼處皮膚有無過敏反應。

(2) 清潔鼻腔及周圍皮膚。

(3) 更換膠布黏貼位置，避免皮膚受刺激或鼻胃管因長時間壓迫鼻腔皮膚引起壓力性損傷。

(4) 每天給予鼻胃管護理並旋轉 45-90 度。

(5) 協助病人執行口腔護理及鼻腔的清潔，使病人舒適，並防止口腔內細菌繁殖。

主題名稱	鼻胃管灌食法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/8

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 唐儷芳(2012)．營養的需要．唐儷芳編著，圖解基本護理學（初版，194-217 頁）．台北市：五南。
- (二) 廖秀珠(2013)．營養的需要．王月琴等編著，基本護理學（下冊）（六版，12-1—12-62 頁）．台北市：永大。
- (三) 蘇麗智(2014)．營養的需要．簡淑貞．劉波兒等編著，實用基本護理學（下冊）（六版，116-121 頁）．台北市：華杏。
- (四) 蘇麗智(2023)．營養的需要．顧家恬編著，實用基本護理學（下冊）（九版，53-114 頁）．台北市：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	鼻胃管灌食法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/8

八、文件正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.04.30	1.0	新制定	89 年 04 月 30 日 護理部技術標準 委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.01.10	2.1	新增：若為主要照顧者灌食時，護理人員應追蹤：胃內容物之存餘量、灌食配方的種類及量、灌食時間及病人反應並於護理紀錄中呈現。	100 年 01 月 10 日 護理部技術標準 委員會通過
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.04.03	3.1	說明內容部份修辭	102 年 04 月 03 日 護理部技術標準 委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.03.17	3.2	1. 第三項第(三)目之 2、4、9、11、14 部份內容刪修。 2. 更改第六項參考資料。	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準 委員會通過
105.03.15	3.3	1.HIS2008 護理系統改為 HIS 系統。 2.增修第三項第(三)目之 2 病人辨識說明。 3.第三項第(三)目之 9 說明新增：尚未消化的食物中若有出血或咖啡色性狀物請告知醫師。 4.新增第六項參考資料。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準 委員會通過
106.03.14	3.4	1.第三項第(三)目之 4、8 部份內容刪修。 2.更新第六項參考資料。	106 年 03 月 14 日 護理部技術標準 委員會通過
107.03.22	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.08.01	3.5	1. 第三項第三目之 9 步驟及要點說明內容修訂。 2. 第三項第三目之 10 新增步驟及要點說明。	107 年 08 月 01 日 護理部週會通過
108.03.18	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 9 說明部份內容文字刪修。 3. 第三項第五目之 3 壓瘡更改為壓力性損傷。	108 年 03 月 18 日 護理技術組會議 通過;108 年 04 月

主題名稱	鼻胃管灌食法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/8

修正日期	版本	修正說明	備註
		4. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	10 日護理長會議通過;108 年 04 月 23 日督導會議通過公布。
109.03.16	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.03.15	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.21	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.05.03	3.7	第三項第二目用物準備：刪除 5.便盆 1 個（視需要）	111 年 03 月 21 日護理技術組會議通過;111 年 04 月 13 日護理長會議通過;111 年 05 月 03 日督導會議通過公布。
112.03.20	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.03.18	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.07.08	3.8	1. 第三項第三目及第四目部分修辭。 2. 第三項第三目之 4 說明 新增「藥物須磨粉泡水(無法磨粉之藥物建議醫師更換藥物)」。 3. 第三項第三目之 6 新增坐臥姿。 4. 第三項第三目之 9 說明固定位置改 55-60 公分 5. 第三項第三目之 10 說明新增胃內容物殘存量少於 50mL，表示消化良好，可給予灌食。 6. 第三項第三目之 10 說明尚未消化的食物修改為胃內容物殘存量。超過 100~120cc 修改為超過 100mL。兩小時後再評估一次修改為一小時。 7. 第三項第三目之 12 說明新增首次灌食量一次不超過 150-250 mL，每 8-12 小時增加 30-60 mL，直到獲取所需的熱量。	114 年 03 月 17 日護理技術組會議通過;114 年 06 月 11 日護理長會議通過;114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	鼻胃管灌食法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
		8. 第三項第三目之 13 說明新增防止配方食物濃度過高，造成高張性脫水。 9. 第三項第三目之 20 說明刪除：若為主要照顧者灌食時 10. 第三項第四目之 1(1)內容修改為使用灌食袋或利用灌食空針重力灌食，一天灌食量平均分 4-6 次灌食。 11. 第三項第四目之 1(2)新增平均一天 8-24 小時持續灌食。 12. 更新第六項參考資料。	
115.04.07	3.9	1.標題鼻胃管灌食法改為鼻胃管灌食技術。 2.刪除 Nasogastric Gavage 英文標題。 3.第三項第二目新增：聽診器 1 付 4.第三項第三目第 2 點新增：及目的，	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過;115 年 03 月 18 日護理長會議通過;115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。